

AI 時代の医療者に求められること

対象：全スタッフ（看護師・介護士・事務職員を含む）

時間：15 分

日付：2026-03-26

ID モデル：ガニエの 9 教授事象

ブルーム：理解 → 適用 → 評価

スライド 1: 知っていますか? この数字 (0-2 分)

「病院で AI を使っている医師が、80% を超えました。」
— AMA (アメリカ医師会) 2026 年調査より

- 2023 年には約 40% だったのが、たった 3 年で 2 倍に
- そのうち 76% 以上が「AI のおかげで診療の質が上がった」と回答

「AI はもう "未来の話" ではなく、"今の話" です。
でも、AI って本当にすごいのか? 怖くないのか?
今日の 15 分で、一緒に考えましょう。」

この 15 分の後、あなたは:

- AI の得意なこと・苦手なことがわかる
- AI が間違える理由をイメージできる
- 自分の仕事で AI とどう付き合うか考えられる

スライド 2: AI の「得意」と「苦手」 （2-5 分）

AI の得意技	身近な例え
-----	-----
大量のデータを素早く処理	何万冊の本を一瞬で検索できる図書館司書
パターンを見つける	「この検査値の組み合わせは要注意」と気づく
24 時間休まず働く	夜勤も疲れも関係なし
同じ作業を正確に繰り返す	書類の転記やデータ入力のプロ

AI の苦手	なぜ苦手?
-----	-----
人の気持ちを理解する	「不安そうな表情」「声のトーン」は数字にできない
文脈を読む	「この患者さんは家族との関係が複雑で ... 」が伝わらない
責任を取る	判断の最終責任は必ず人間にある
「なんとなくおかしい」に気づく	ベテランの直感や経験は数値化できない

たとえばなら：

AI は「ものすごく優秀だけど、空気が読めない新人スタッフ」。
データの処理は速いけど、患者さんの涙の意味はわからない。

スライド 3: AI も「間違える」 — 知っておいてほしい話（5-8分）

最新の研究（PNAS 2026 年発表）で、AI の「くせ」がわかってきました：

例えば話：

「廊下で患者さんが転びそうになっている。

手を出して支えたら → もしケガさせたら自分のせい？

何もしなかったら → たまたま転んだだけ？」

AI は「何もしない方が安全」と判断しがちです。

でも医療では、「何もしないこと」も判断であり、責任がある。

最初に見た数字に影響されて、後から入った情報を軽視してしまう。

人間にもある「くせ」ですが、AI はこれをさらに強めてしまうことがある。

「成功率 90% の手術です」と聞くと安心するけど、

「10 人に 1 人は失敗します」と聞くと不安になる。

同じことなのに、伝え方で印象が変わる — AI にもこの傾向がある。

AI の答えを「そのまま信じる」のではなく、「本当かな？」と立ち止まる。

これが、AI 時代に一番大切なスキルです。

スライド 4: 実際の医療現場ではどう使われている? (8-9分)

BJC Healthcare という病院グループでは:

- 35,000 人以上の患者データをもとに
- AI が「この患者さんは今後のケア計画について話し合うタイミングかもしれません」と提案
- 最終判断は必ず医師やケアチームが行う

ポイント : AI は「提案する」だけ。「決める」のは人間。

これまで	これから
-----	-----
スタッフだけでカンファレンス	AI が事前に情報を整理してくれる
手作業でデータを集計	AI が自動で傾向をまとめてくれる
経験と勘で優先度を判断	AI が「見落とし」を減らす手伝い

AI はチームの一員。でも、リーダーは常に人間です。

スライド 5: みんなで考えよう (9-13 分)

3-4 人のグループで話し合ってみましょう:

テーマ:

「あなたの業務の中で ...」

1. AI に手伝ってもらいたいことは?
2. 絶対に人がやるべきことは?

考えるヒント:

- 毎日繰り返しているデータ入力や記録作業は?
- 「ダブルチェック」で時間がかかっている業務は?
- 患者さんやご家族と直接向き合う場面は?
- 「この仕事、間違えたら大変」という判断業務は?

考え方のコツ:

「AI に任せて楽になること」と「人間だからこそ意味があること」を分けてみよう。

- 各グループから 1 つずつ共有

スライド 6: まとめ — だから、あなたが大切（13-15 分）

	ポイント	ひとことで
---	-----	-----
1	AI は便利だけど万能じゃない	得意なことと苦手なことがある
2	AI も間違える・偏る	「本当かな? 」と立ち止まる習慣が大切
3	人間にしかできないことがある	患者さんに寄り添えるのはあなただけ

テクノロジーは変わります。
でも、患者さんの手を握れるのは、あなただけです。
AI が得意なことは AI に任せて、
あなたにしかできないこと — 笑顔、声かけ、気づき、寄り添い —
に、もっと時間を使えるようになる。
それが「AI と一緒に働く未来」です。

「今日聞いた話の中で、1 つだけ誰かに伝えるとしたら、何を選びますか? 」

- 日常業務の中で「これ、AI に手伝ってもらえないかな? 」とアンテナを立ててみる
- AI の答えに接したとき「本当かな? 」と一度立ち止まってみる
- わからないことがあれば、いつでも相談してください

参考文献

- AMA (2026) — 医師の AI 活用調査（80% 超が臨床で AI 活用）。IME 2026 Conference, University of Miami Miller School of Medicine. <https://news.med.miami.edu/innovations-in-medical-education-2026-explores-the-power-of-ai/>
- AMA (2026) — Boost health AI training across medical education continuum. <https://www.ama-assn.org/practice-management/digital-health/boost-health-ai-training-across-medical-education-continuum>
- Healthcare IT News (2026) — BJC Healthcare ACO, マルチ AI エージェントによる臨床意思決定支援（HIMSS26 発表）。<https://www.healthcareitnews.com/news/how-multi-ai-agents-can-improve-clinical-decision-support>
- PNAS (2026) — LLM の認知バイアス増幅に関する研究（不作為バイアス・フレーミング効果）。<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2412015122>

ファシリテーター向けメモ

- [] プロジェクター or モニター
- [] タイマー（グループワーク 3 分計測用）
- [] 付箋（グループワーク用、任意）

- スライド 1: 「80%」の数字を最初に見せてインパクトを与える。「自分も AI 使ったことある? 」と問いかけて参加感を出す
 - スライド 2: 「空気が読めない新人スタッフ」の例えは笑いを誘いやすい。場が和んだところで「でも仕事は速い」と続ける
 - スライド 3: バイアスの話は難しくなりがちなので、必ず例え話で説明する。「転びそうな患者さん」の例は全職種がイメージしやすい
 - スライド 4: 「AI は提案、人間が決定」を繰り返し強調する
 - スライド 5: グループワークでは「正解はない」ことを最初に伝える。迷うこと自体が学び
 - スライド 6: 最後のメッセージは落ち着いたトーンで。「あなたが大切」を心を込めて
-
- 3/21 版: 「AI エージェント」の概念紹介が中心（AI チームの比喻）
 - 今回: 「最新データで見る AI の光と影」がテーマ。AI の限界やバイアスにも踏み込んだ内容
 - 両方受けた方には: 「前は "AI って何ができるか"、今回は "AI とどう付き合うか" 」と伝える